جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : روحيه صبره محمد حجازي
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** اوسيم **العنوان :** اوسيم
رقم البطاقة : 26505172100921 **رقم التليفون :** 01121457900 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 20-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 17-05-1965 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام اشعه مقطعيه علي الصدر والبطن والحوض بالصبغه [11129] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: روحيه صبره محمد حجازي
National ID: 26505172100921

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen, and pelvis

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL

Patient Name	: الأستاذه / روحيه صبره محمد حجازى	Request No.	: 13009209
Patient No.	: 26505172100921	Request Date	: 23/11/2024
Path No.	: 4548/24	Verification Date	: 12/12/2024
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - مبادره
Age	: 59 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Diagnosis:
Left breast cancer post NACT, MRM specimen:
Invasive duct carcinoma, Grade III.
- Maximal tumor diameter: 3.5 cm.
- Actual tumor cellularity: 80%, tumor necrosis index: 20%.
- Free resection margin.
- Free skin.
- Negative lymph nodes (0/15).
- Partial pathological response to therapy.
- Stage: ypT2, ypN0
- RCB: 2.344, RCB class II.

Signature
Prof. Dr. Amal Ahmed Hareedv.
Dr. Rufaida Abdullah.

Verified by :

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL

Patient Name	: الأستاذه / روحيه صبره محمد حجازى	Request No.	: 13009209
Patient No.	: 26505172100921	Request Date	: 23/11/2024
Path No.	: 4548/24	Verification Date	: 12/12/2024
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - مبادره
Age	: 59 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, post NACT.
Nature Specimen: Left modified radical mastectomy specimen.

Gross Examination:
* Procedure: Left MRM measured 21x18x5 cm with covering skin ellipse measured 17x10 cm.
* Tumor extent: A greyish white rubbery to firm tumor bed site.
* Size: 3.5 x3 x2.5 cm.
* Skin involvement: Mass located just below the skin with overlying pigmented area, no skin ulcers.
* Distance from margins: 2 cm away from deep margin.
* Lymph nodes number and size: 15 L.Ns up to 2.5x1 cm.
Designation: 1,2,3) TBS. 4) TBS with skin. 5) Deep margin. 6) Nipple & areola. 7,8) LNs
Grossing by Dr. Samia Ali.

Microscopic Examination:
* Histological type: Invasive duct carcinoma.
* Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+3+2) Grade III.
- Maximal tumor diameter 3.5 cm.
- Actual tumor cellularity: 80%, tumor necrosis index: 20%.
* Ductal carcinoma in situ: Present, (20%), reaching main lactiferous ducts.
* Lymphovascular invasion: Not identified.
* Perineural invasion: Not identified.
* Skin involvement: Free.
* Resection Margin: Free.
* Lymph node involvement: Negative (0/15), with hemosiderin granules.
* Histologic response to therapy: Partial.
* Microcalcifications: Not identified.

Verified by :

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

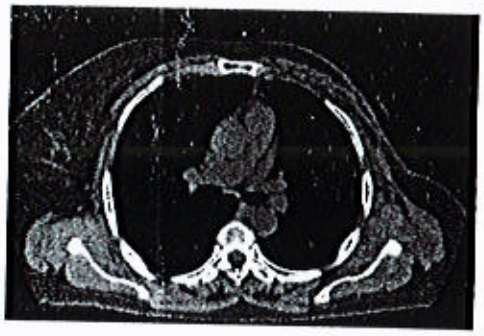
ROUSSY
INTERNATIONAL
EGYPT

Patient Name: Rawheya Sabra Mohamed Hegazy Khaled	Date : 20/07/2025
Exam : C.T CHEST	Age : 60 Year(s)
Medical ID:	Pat. ID: 46021

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST

No available previous films for comparison.

Findings:



- The left mastectomy bed shows minimal fat stranding yet no definite soft tissue masses to account for residual/recurrent neoplasia.
- Both lungs show normal appearance of its parenchyma with no evidence of sizable nodules, masses or consolidative patches.
- No sizable hilar or mediastinal lymph nodes regarding this non contrast study.
- Patent tracheo- bronchial tree.
- Average size of the heart.
- No evidence of pleural effusion.
- Minimal pericardial effusion is noted.
- The lower neck cuts revealed bulky left thyroid gland for ultrasound correlation.

OPINION:

- ***Left mastectomy bed minimal fat stranding yet no definite soft tissue masses to account for residual/recurrent neoplasia.***

Marina Essam, MSc
Dr.Noura Nabil,MD

Signature Noura Nabil
09/08/2025 7:42 PM

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

USTAVE
OUSSY
NATIONAL

Patient Name	: الأستاذه / روحيه صبره محمد حجازى	Request No.	: 13009209
Patient No.	: 26505172100921	Request Date	: 23/11/2024
Path No.	: 4548/24	Verification Date	: 23/07/2025
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - مبادره
Age	: 59 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Left breast cancer, Post-NACT.
Nature of Specimen: Left modified radical mastectomy.

Technique:
Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against:
ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Results:
IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
- ER: Negative nuclear staining in tumor cells (score 0/8).
- PR: Faint nuclear staining in less than 1% of tumor cells (score 2/8).
- Her2: Negative membrane staining in tumor cells (score 0).
- Ki67%: 70%.

Conclusion:
Left breast cancer (Post-NACT), Left modified radical mastectomy:
- Residual invasive duct carcinoma, Grade 3, with 20% DCIS.
- Cellularity: 80%.

PT:
- ER: Negative (score 0/8).
- PR: Negative (score 2/8).
- Her2: Negative (score 0).
- Ki67%: 70%.

* Scoring system: "ER, PR"

Verified by :

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Patient Name	الأستاذه / روحيه صبره محمد حجازى	Request No.	13009209
Patient No.	26505172100921	Request Date	23/11/2024
Path No.	4548/24	Verification Date	23/07/2025
Sex	Female	Financial Category	جوستاف رومي - مبادره
Age	59 Y	Department	Out Patient
Referreing Doc.		Registered by	.marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

* Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013.IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of

the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature
Dr. Walaa Ibrahem Ghoneim.
Dr. Heba Hassan Adly.

Verified by :

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]